PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

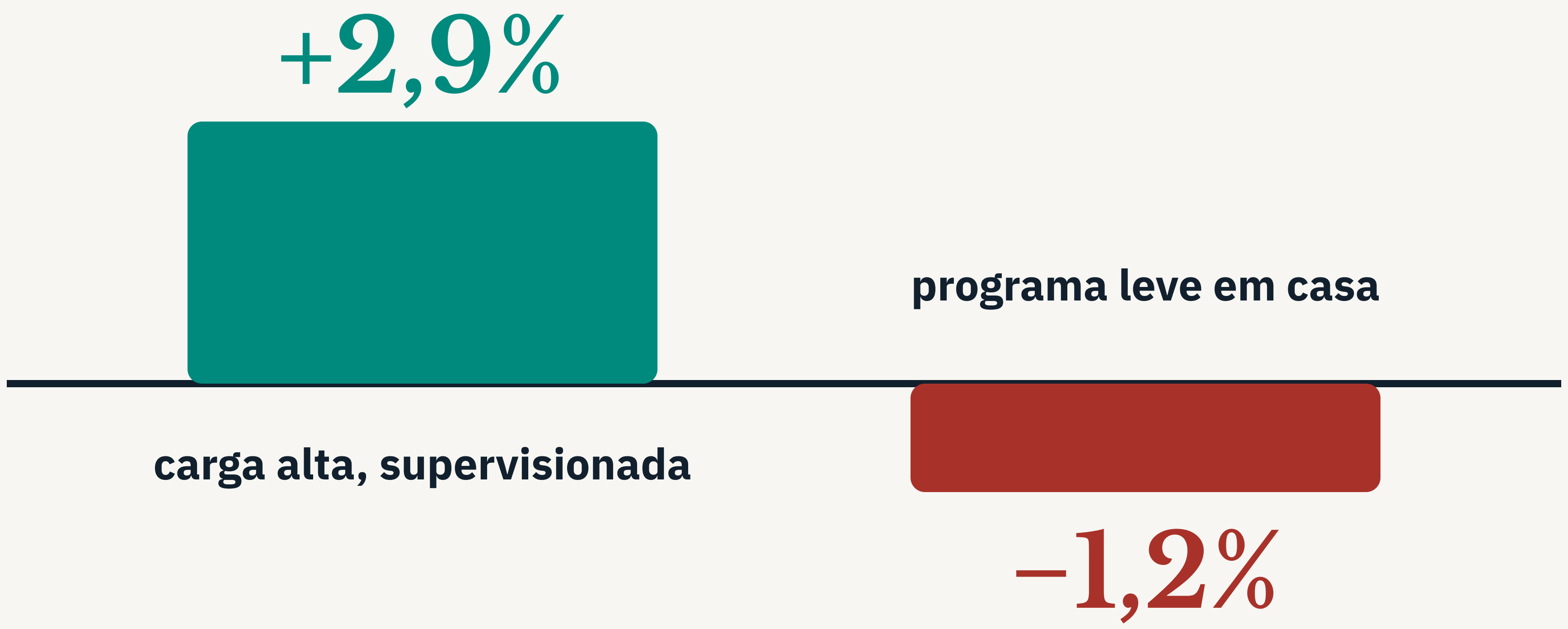
Transição da menopausa

Mais carga, melhor atribuição, menos mercado

A Atleta Mulher

UMA JOGADORA DE BEACH TENNIS, NA CASA DOS CINQUENTA

O osso baixo respondeu à carga pesada, não à leve



densidade da coluna lombar em oito meses

Ensaio randomizado, J Bone Miner Res 2018

A receita

- 2 sessões por semana
- 30 minutos cada
- 5 séries de 5, acima de 85% da carga máxima
- agachamento, terra, desenvolvimento
- mais impacto

EM QUEM FOI MEDIDO

Seguro e bem aceito, desde que supervisionado

101

mulheres, acima de 58 anos, osso baixo

92%

de adesão no grupo da carga alta

0

fratura vertebral nova ou piorada

1

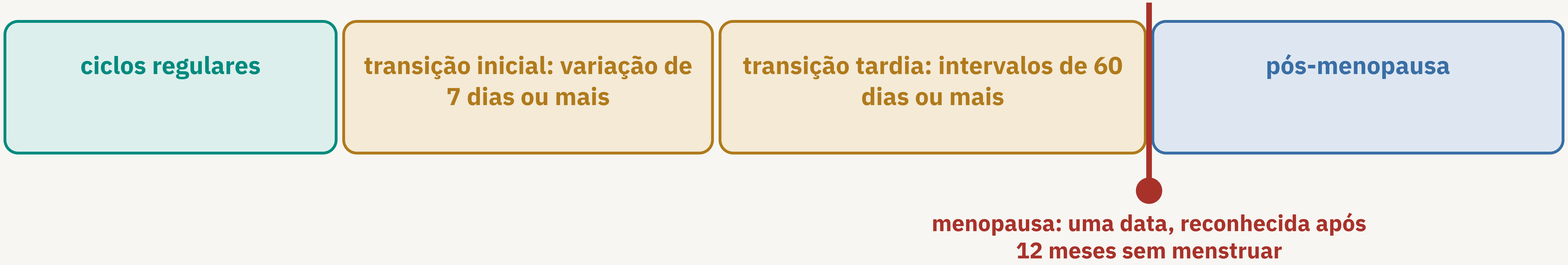
evento adverso, leve

Vai junto com o número

- supervisionado
- técnica ensinada, progressão conduzida
- fratura vertebral prévia muda a indicação

OS NOMES

Menopausa é uma data; a transição é o que vem antes



ciclos regulares

transição inicial: variação de 7 dias ou mais

transição tardia: intervalos de 60 dias ou mais

pós-menopausa

menopausa: uma data, reconhecida após 12 meses sem menstruar

FSH oscila na transição: o diagnóstico é pela história

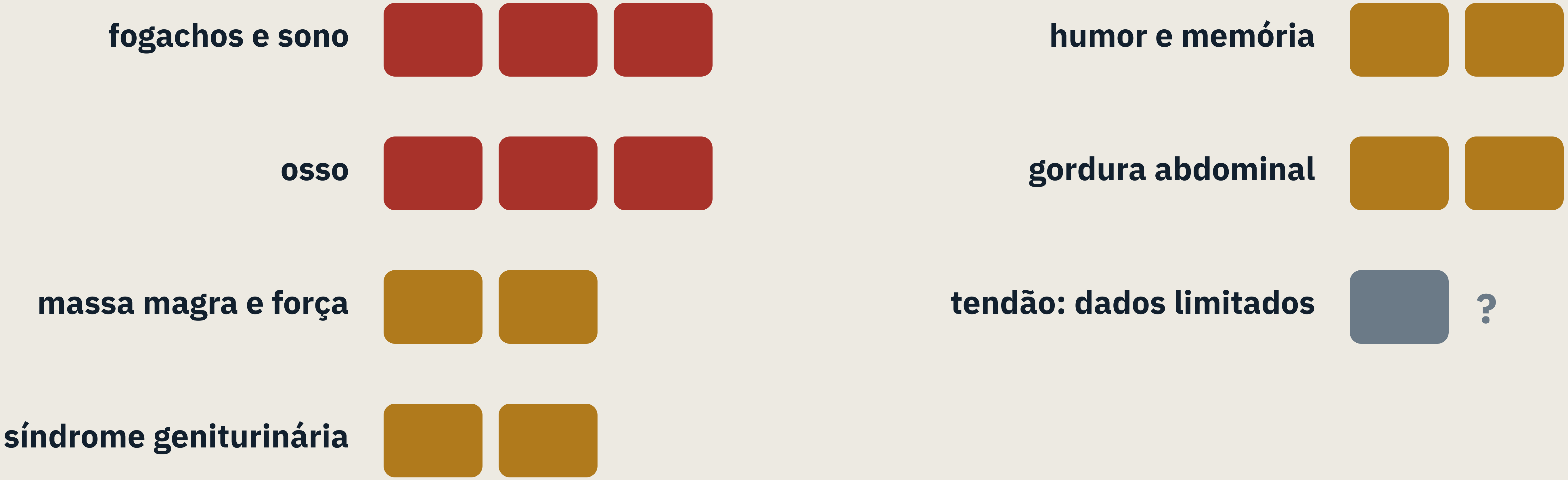
antes dos 45: precoce · antes dos 40: insuficiência ovariana

enquanto há ciclo, há chance de gravidez

Estadiamento revisto, Fertil Steril 2012

O QUE MUDA, E COM QUE PESO

O sono e o osso pesam mais; o tendão ainda é pergunta



fogachos e sono 🟥🟥🟥

osso 🟥🟥🟥

massa magra e força 🟧🟧

síndrome geniturinária 🟧🟧

humor e memória 🟧🟧

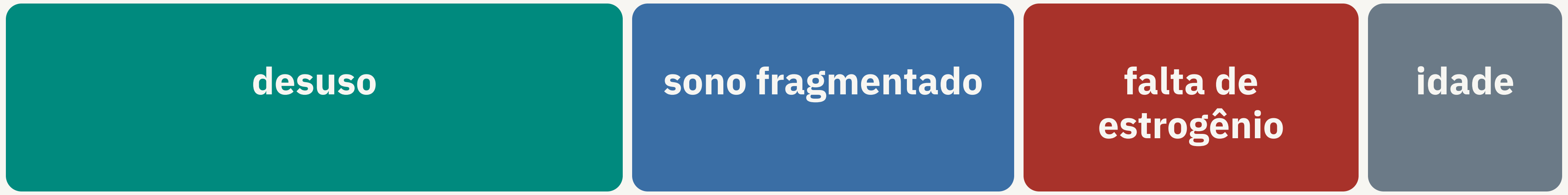
gordura abdominal 🟧🟧

tendão: dados limitados ⬜ ?

A FERRAMENTA CLÍNICA

Antes de dizer “é a menopausa”, divida a queixa

“a força caiu e o ritmo piorou”


desuso
sono fragmentado
falta de estrogênio
idade

esquema: as fatias variam de mulher para mulher

várias costumam coexistir: todas entram no plano, a ordem é que muda

Existe outra explicação, provável e mais tratável? Trate essa primeiro.

O QUE O TREINO FAZ

Pelo osso, pela força, pelo sono e pelo coração; não pelo fogacho

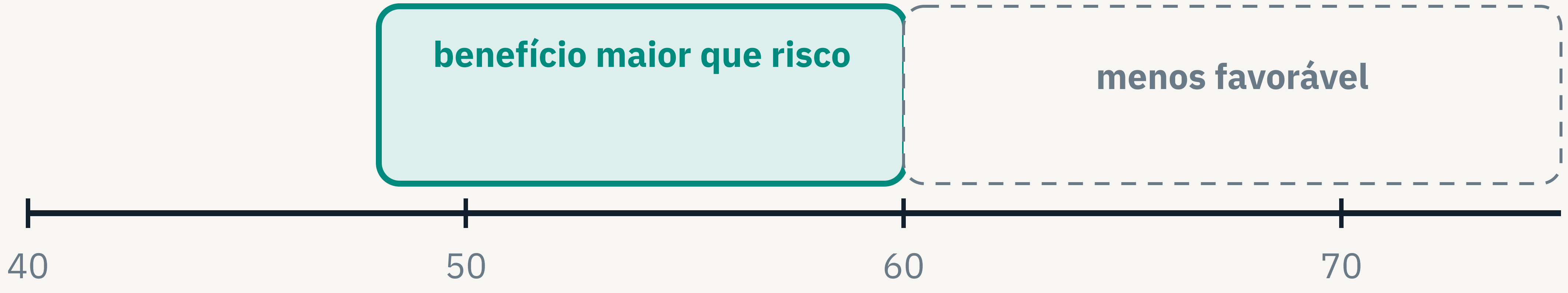
- força pesada, supervisionada
- impacto progressivo
- proteína distribuída
- aeróbico

~~exercício para tratar fogacho~~

evidência insuficiente (revisão de 2014)

POSICIONAMENTO DE 2022

Terapia hormonal: eficaz, com janela definida


benefício maior que risco
menos favorável
40
50
60
70

antes dos 60 anos ou até 10 anos da menopausa · fogachos incômodos e prevenção de perda óssea

estrogênio vaginal em dose baixa: síndrome geniturinária

decisão médica, compartilhada

Sociedade norte-americana de menopausa, Menopause 2022

O QUE NÃO É INDICAÇÃO

O que a mesa vende não trata o que ela tem

~~hormônio para desempenho~~

~~testosterona para força ou composição corporal~~

~~implante manipulado acima da dose fisiológica~~

~~“bioidêntico” como argumento~~

⚠ **Atleta federada: terapia hormonal e testosterona têm implicações antidoping**

FECHO DO MÓDULO · TRÊS NÍVEIS

Do déficit de evidência à mulher que treina depois dos cinquenta

- ✓ Decisão: a medicina e a ginecologia investigam e decidem sobre hormônio; a nutrição corrige a energia; preparação e fisioterapia conduzem carga, prevenção e retorno
- ✓ Contribuição: o ciclo registrado, o rendimento que parou, o prato contado, a lesão que se repete, o encaminhamento em seis linhas
- ✓ Reconhecimento: o ciclo que espaçou, a fratura que volta, o platô com treino mantido, a perda urinária, a gestante parada, a carga leve para osso fraco

Medicina e ginecologia

Funil de exclusão, densitometria, contracepção, terapia hormonal, liberação.

Nutrição, preparação e fisioterapia

Energia, programa de prevenção, gestação, assoalho pélvico, carga.

Todos

Próximo módulo: o atleta adolescente e o atleta idoso, a começar pelo crescimento.